Medical Consultation Report

Patient Information

Patient Name	Likhovod Kirill
Gender	Male
Date of Birth	September,19, 1998
Diagnosis	Diffuse Large B-cell Lymphoma

Hospital Highlights

1. Precision and Individualized Treatment Design

Therapeutic strategies are developed based on each patient's genetic and molecular profile, combining precision chemotherapy, cellular immunotherapy, and targeted maintenance therapy. This approach enhances efficacy while reducing adverse effects.

2. Multidisciplinary and One-Stop Management

A fully integrated Multidisciplinary Team (MDT) — encompassing hematologic oncology, imaging, pathology, neuro-rehabilitation, and cellular therapy — provides customized and coordinated care for every international patient.

3. Priority Channel for International Patients

We offer an expedited service pathway, including rapid pathology review and a green-channel admission process, ensuring that treatment can begin immediately upon arrival, without missing the optimal therapeutic window.

Doctor's Consultation

After two lines of chemotherapy, the patient developed new lesions with central nervous system involvement and increased SUV values in the original mediastinal lesions, indicating a relapsed/refractory condition. In such cases, a combination of autologous hematopoietic stem cell transplantation (auto-HSCT) and CAR-T therapy is recommended. For high-risk patients, the synergistic effect of auto-HSCT combined with CAR-T therapy aims to achieve deeper remission and prolong survival.

Given that the current patient data lacks pathological results, it is now recommended to complete the following critical evaluations to support the precise selection of subsequent CAR-T cell therapy

targets: It is advised to conduct a pathological review of the original tumor tissue, focusing on the expression of CAR-T-related targets such as CD19, CD20, CD22, etc. If local testing cannot be completed or the processing cycle is excessively long, consider borrowing pathological unstained slides or paraffin-embedded tissue blocks to bring to China for supplementary analysis.

Treatment Plan

Phase I: Precise Re-assessment Upon Admission

1. Tumor Burden and Classification Confirmation: Re-check bone marrow aspiration (morphology + flow cytometry); perform bone marrow biopsy with immunohistochemistry.
2. Whole-body PET/CT: Confirm the extent of tumor infiltration.
3. Re-assess Organ Function, Echocardiogram, and Infection Screening: Evaluate organ function and treatment tolerance through infection screening.

Phase II: Cell Collection and Cytoreductive Chemotherapy, including:

1.Lymphocyte collection

2.Mobilization chemotherapy, stem cell collection, and cryopreservation

3.Supportive care for hematologic recovery after chemotherapy

Phase III ： Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation as a Bridging Strategy to CAR-T Cell Therapy

Treatment Steps:

(1) T cell collection:
For allogeneic CAR-T, T cells will be collected from the related donor.

For autologous CAR-T, T cells will be collected from the patient.

(2) Cell preparation:
T cells will be genetically engineered to express chimeric antigen receptors (CARs) targeting T-ALL-specific markers.

(3) Lymphodepleting chemotherapy:
A chemotherapy regimen will be administered to reduce tumor burden and create a favorable environment for CAR-T cell engraftment.

(4) CAR-T infusion:

The prepared CAR-T cells will be infused intravenously. The patient will be closely monitored for cytokine release syndrome (CRS), neurotoxicity, and other potential adverse events, with particular attention to complications related to the patient's history of thrombosis and seizures.

CAR-T cell therapy is an innovative immunotherapy that involves genetically engineering T cells to specifically recognize and destroy tumor cells. Based on this unique mechanism of action, CAR-T cells can precisely target leukemic cells and overcome the issue of drug resistance commonly seen with traditional chemotherapy.

Phase IV: Post–CAR-T Infusion Monitoring and Response Assessment

This therapy is a form of strong cellular immunotherapy and may be accompanied by severe adverse reactions, such as cytokine release syndrome (CRS), neurotoxicity, and others. However, as our hospital is the single center with the highest number of CAR-T cases globally, we have the most experienced professional medical team to help patients through the observation period of the treatment.

Estimated Treatment Duration and Cost (Based on an exchange rate of 1 USD = 7RMB; final costs will be calculated based on the actual exchange rate upon admission. Hospitalization fees are settled in RMB)

Breakdown:

Therapeutic procedure	Estimated Time Duration	Items	Cost Estimation (RMB)	Cost Estimation (USD)
Step 1. Pre-treatment Assessment Including assessment of organ function and tumor evaluation				
Pre-treatment assessment (special blood tests & image exams)	3-5 days	Bone Marrow Aspiration exams (morphology, flow cytometry, gene mutation, chromosome test, bone marrow biopsy etc.） Lumbar Puncture (including CSF flow cytometry）	70,000-100,000	10,000-14,286
		Blood Test (including		

		Biochemical Test, Infection-related Items) PET-CT, Lung-CT (optional), Echo, abdominal ultrasound, Brain MRI, ECG, Minimal Residual Disease		
Step 2. Cell collection and cytoreductive chemotherapy				
Tumor burden reduction therapy	4 weeks	① Lymphocyte collection ②Mobilization chemotherapy, stem cell collection, and cryopreservation ③ Supportive care for hematologic recovery after chemotherapy	100,000-150,000	14,286-21,429
Step 3. Autologous hematopoietic stem cell transplantation combined with CAR-T cell therapy				
①CAR-T Cell Preparation		T Cell Cryopreservation Culturing of CAR T-cell T-cell sorting Cell Thawing and Pre-infusion Processing	234,000	33,429
②Conditioning chemotherapy	5 days	Autologous hematopoietic stem cell infusion, CAR-T cell infusion	150,000-250,000	21,429-35,714
Step 4. Post-infusion monitoring and efficacy assessment				
Management of Post-CAR-T Infusion Complications	21-30 days	① Cytokine Release Syndrome (CRS) ② Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome (ICANS) ③ Infection Prevention Associated with Immunosuppression ④ Management of	180,000-260,000	25,714-37,143

		Hematologic Toxicity ⑤ Other Supportive Care		
Monitoring and Efficacy Evaluation After CAR-T Infusion		① Blood Tests (Including Biochemical, Infection-related Markers, etc.) ② Imaging Examinations ③ CAR-T Cell Detection and Immune Function Testing ④ Tumor Evaluation: Minimal Residual Disease (MRD) Detection		
Granulocyte Engraftment After Hematopoietic Stem Cell Infusion				
Total Hospitalization	57-68 days	Bed Fee: 2,000 CNY/day Medical Service Fee: 1,000 CNY/day Nursing Fee: 900 CNY/day Pharmacy Service Fee: 2,000 CNY/week	222,300-265,200	31,757-37,886
Total amount（including step1.2.3.4）		Above all	956,300-1,259,200	136,614-179,886
The above costs are estimated based on the patient's current physical condition. As the condition progresses, the treatment plan may change, and the costs may also vary.				

The cost includes:

1.Single-room accommodation

2.All necessary tests as per the treatment plan

3.Medications, cell immunotherapy, and other treatment costs in accordance with the treatment plan

4.Routine medical services, doctor consultations, examinations, laboratory tests, etc.

The payment doesn't include:

1. Food;
2. Discharge medicine;
3. Unexpected treatment and examination such as life-threatening infection, serious CRS, CRES or ICU fees.
4. Treatment for unrelated disease;
5. Unexpected emergency management;
6. Personal expenses such as phone calls, flight tickets.

Payment Terms:

Initial Deposit: A minimum initial deposit of 40,000 USD equivalent to 288,000 RMB is required upon admission to the hospital. This deposit will be applied towards the estimated total cost of treatment.

Final Payment: The remaining balance will be due upon completion of the treatment. Any additional costs incurred during the treatment process will be added to the final payment, and any unused funds from the initial deposit will be refunded.

Important considerations before treatment:

Given the complexity of your condition, we strongly recommend scheduling a one-on-one personalized online consultation with Dr. Jiang, our lead hematology expert with extensive experience in managing Diffuse Large B-cell Lymphoma. This exclusive, appointment-based consultation service will provide you and your family with:

(1)A detailed assessment of your current medical condition

(2) Preliminary treatment recommendations tailored to your specific situation

(3) The opportunity to directly ask critical questions to a senior specialist

As part of our commitment to international patients, this consultation is USD 150 per 30 minutes.

Due to Dr. Jiang's demanding clinical schedule, availability is limited, so we encourage you to confirm your interest as early as possible to secure an appointment.

We provide free English translation services. For other languages, professional interpretation can be arranged upon request (USD 100 per 30 minutes), or you are welcome to bring your own interpreter.

Important Notes

1). The above preliminary treatment plan is based on the information provided by the patient and/or

their representative. Upon hospital admission, a comprehensive re-evaluation will be conducted. If there are significant discrepancies between actual condition and previously submitted history or test results, the treatment plan and costs may be adjusted accordingly after discussion with the patient and/or legal guardian.

2). For the side effects of CAR-T therapy, particularly cytokine release syndrome (CRS) and neurotoxicity, close monitoring and timely intervention are recommended. The occurrence of CRS varies depending on individual differences, and the hospital has a comprehensive response system in place. After treatment, the hospital will provide detailed treatment records and follow-up plans to ensure that the patient receives support and monitoring upon returning home, focusing on disease recovery and potential side effects, with necessary adjustments to the treatment plan.

3). One week prior to admission, it is necessary to provide recent external laboratory test reports and the patient's general condition, such as:

A recent week's complete blood count (CBC) report to assess for bone marrow suppression or infection risk.

Liver and kidney function reports, as well as cardiac function reports, to ensure the patient can tolerate chemotherapy.

Infection control status, to confirm whether the patient has a severe infection.

Physical condition assessment, especially to check for symptoms of GVHD (graft-versus-host disease).

Blood type and RH blood type reports, in preparation for using donor cells during treatment.

We provide one-stop international patient services, including visa assistance, medical translation and accompaniment, remote consultations, and rehabilitation support.

We understand that seeking medical treatment abroad is a physical and emotional challenge for both patients and their families. Our hospital provides multilingual support, cultural sensitivity, personalized meals, assistance with accommodation and transportation, and family companion services to create a safe and welcoming environment. From airport pickup and admission to recovery and follow-up, our international patient service team will accompany you throughout the entire process. Rest assured, we are committed to offering professional guidance and compassionate care to ensure your treatment journey is clear, reassuring, and well-managed.

Prof. Jiang ying

GoBroad ShangHai ZhaXin Hospital

Date: January 14, 2026

GHG GoBroad Healthcare Group 高博医疗集团

蒋瑛

Dr. Ying Jiang

高博医疗集团上海闸新医院医疗组长

第 12 届上海市医学会血液学专科分会白血病学组成员

血液病数字诊疗专业委员会委员

2014 年赴美国梅奥诊所免疫实验室做访问学者

参与多项市科委和国自然课题项目

曾获得 2017 年中华医学会科技进步国家二等奖,2016 年上海医学科技奖三等奖；

2008 年上海医学科学进步奖三等奖

擅长：各类血液病的诊断及治疗，主要从事血液肿瘤的自体及异基因造血干细胞移植和 CAR-T 等细胞免疫治疗和淋巴瘤免疫治疗的相关研究。

Deputy Chief Physician, Medical Team Leader

Dr. Jiang holds the following prominent positions: Member of the Leukemia Group under the Hematology Specialty Committee and the Digital Diagnosis and Treatment Committee of the Shanghai Medical Association, and former attending physician in the Hematology Department of the First People's Hospital of Shanghai, graduated with a doctoral degree from Shanghai Jiao Tong University School of Medicine. In 2014, Dr. Jiang visited the Immunology Laboratory at Mayo Clinic as a visiting scholar. She has participated in multiple research projects funded by the municipal science and technology commission and the National Natural Science Foundation. Her main research accomplishments include personalized MRD monitoring and treatment after HSCT, and immunotherapy for hematological malignancies. She has published articles in Frontiers in Medicine and the Journal of Clinical Hematology.

Areas of expertise: Diagnosis and treatment of malignant hematological diseases, researches related to immunotherapy for lymphoma, CAR-T therapy and administration, and bridge therapies to transplantation.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Логотип GoBroad Healthcare Group

ОТЧЕТ О МЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Имя пациента	Лиховод Кирилл
Пол	Мужской
Дата рождения	19 сентября 1998 г.
Диагноз	Диффузная В-крупноклеточная лимфома

Ключевые преимущества госпиталя

1. Точный и индивидуализированный подход к лечению
Терапевтические подходы разрабатываются с учётом генетического и молекулярного профиля каждого пациента и включают прецизионную химиотерапию, клеточную иммунотерапию и таргетную поддерживающую терапию. Такой подход позволяет повысить эффективность лечения и снизить риск побочных эффектов.

2. Многопрофильное и комплексное лечение
Мультидисциплинарная команда (MDT), объединяющая специалистов в области гематологической онкологии, лучевой диагностики, патологии, нейрореабилитации и клеточной терапии, обеспечивает комплексный, скоординированный и индивидуализированный подход к лечению каждого международного пациента.

3. Приоритетный канал для международных пациентов
Предоставляется ускоренный маршрут оказания помощи, включая срочный пересмотр гистологии и «зелёный коридор» госпитализации, что позволяет начать лечение сразу после прибытия, не упуская оптимальные терапевтические сроки.

Заключение врача

После двух линий химиотерапии у пациента появились новые очаги поражения с вовлечением центральной нервной системы, а также отмечено повышение значений SUV в исходных медиастинальных очагах, что свидетельствует о рецидивирующем/рефрактерном течении заболевания. В таких случаях рекомендуется комбинация аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ауто-ТГСК) и CAR-T терапии. Для пациентов высокого риска синергетический эффект сочетания ауто-ТГСК и CAR-T терапии направлен на достижение более глубокой ремиссии и увеличение продолжительности жизни.
В связи с тем, что в настоящее время в данных пациента отсутствуют патоморфологические результаты, рекомендуется провести следующие ключевые обследования для обеспечения точного выбора мишеней последующей CAR-T-клеточной терапии:

Рекомендуется выполнить патоморфологический пересмотр первичной опухолевой ткани с акцентом на экспрессию мишеней для CAR-T, таких как CD19, CD20, CD22 и др.

Если проведение данных исследований по месту жительства невозможно либо сроки выполнения анализа чрезмерно длительные, следует рассмотреть возможность временного получения (заимствования) неокрашенных гистологических срезов или парафиновых блоков опухолевой ткани для доставки в Китай с целью проведения дополнительного анализа.

План лечения

Фаза I: Углубленное обследование при поступлении

1. Оценка опухолевой нагрузки и подтверждение классификации:
   - Повторная аспирация костного мозга (морфология + проточная цитометрия)
   - Биопсия костного мозга с иммуногистохимией
2. ПЭТ/КТ всего тела: для оценки степени опухолевого поражения
3. Повторная оценка функции органов, эхокардиография и скрининг на инфекции: оценка функции органов и переносимости лечения, а также исключение инфекций.

Фаза II: Сбор клеток и циторедуктивная химиотерапия, включая:

1. Сбор лимфоцитов
2. Подготовительный (мобилизационный) курс химиотерапии для сбора стволовых клеток, сбор стволовых клеток и криоконсервация
3. Поддерживающая терапия для восстановления гематологических показателей после химиотерапии

Фаза III Аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в качестве подготовительной стратегии к CAR-T клеточной терапии

Этапы лечения:
(1) Сбор Т-клеток:
Для аллогенной CAR-T-терапии Т-клетки будут получены от родственного донора.
Для аутологичной CAR-T-терапии Т-клетки будут получены от пациента.
(2) Подготовка клеток:
Т-клетки будут генетически модифицированы для экспрессии химерных антигенных рецепторов (CAR), нацеленных на специфические маркеры опухоли.
(3) Лимфодеплетирующая химиотерапия:
Будет назначен режим химиотерапии для снижения опухолевой нагрузки и создания благоприятных условий для приживления CAR-T-клеток.
(4) Инфузия CAR-T-клеток:
Подготовленные CAR-T-клетки будут введены внутривенно. Пациент будет находиться под пристальным наблюдением на предмет синдрома выброса цитокинов (CRS), нейротоксичности и других потенциальных нежелательных явлений, с особым вниманием к осложнениям, связанным с наличием тромбозов и судорог в анамнезе.

Терапия CAR-T-клетками — это инновационный метод иммунотерапии, включающий генную модификацию Т-клеток для специфического распознавания и уничтожения опухолевых клеток. Благодаря этому уникальному механизму действия CAR-T-клетки способны точно воздействовать на опухолевые клетки и решать проблему лекарственной устойчивости, часто встречающуюся при традиционной химиотерапии.

Фаза IV: Мониторинг после инфузии CAR-T и оценка ответа

Данный метод относится к интенсивной клеточной иммунотерапии и может сопровождаться тяжёлыми побочными реакциями, такими как синдром высвобождения цитокинов (CRS), нейротоксичность и др. Однако, поскольку наша клиника является центром с наибольшим количеством случаев CAR-T терапии в мире, у нас имеется высококвалифицированная медицинская команда для безопасного ведения пациентов в период наблюдения.

Предполагаемая продолжительность лечения и стоимость (исходя из обменного курса 1 доллар США (USD) = 7 юаней (RMB); окончательная стоимость будет рассчитана по актуальному курсу на момент поступления. Оплата госпитализации производится в юанях)

Детализация:

Лечебная процедура	**Предполагаемая продолжительность**	**Пункты**	**Оценка стоимости (RMB)**	**Оценка стоимости (USD)**
Шаг 1. Предварительное обследование, направленное на оценку функционального состояния органов и опухолевого процесса.				

Предварительное обследование (специальные анализы крови и визуальные исследования)	3-5 дней	Аспирация костного мозга (морфология, проточная цитометрия, мутации генов, хромосомный тест, биопсия костного мозга и т.д.), Люмбальная пункция (включая проточную цитометрию ликвора), Анализы крови (включая БХ, маркеры инфекций), ПЭТ-КТ, КТ легких (по показаниям), ЭхоКГ, УЗИ брюшной полости, МРТ головного мозга, ЭКГ, МОБ	70,000-100,000	10,000-14,286
Шаг 2. Забор клеток и циторедуктивная химиотерапия				
Терапия по уменьшению опухолевой массы	4 недели	① Забор лимфоцитов ②Мобилизационная химиотерапия, сбор стволовых клеток и криоконсервация ③ Поддерживающая терапия для восстановления кроветворения после химиотерапии	100,000-150,000	14,286-21,429
Шаг 3. Аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток в сочетании с CAR-T-клеточной терапией				
① Приготовление CAR-T-клеток		Криоконсервация Т-клеток Культивирование CAR-T-клеток Сортировка Т-клеток Размораживание и обработка клеток перед инфузией	234,000	33,429
②Кондиционирующая химиотерапия	5 дней	Инфузия аутологичных гемопоэтических стволовых клеток, Инфузия CAR-T-клеток	150,000-250,000	21,429-35,714
Шаг 4. Мониторинг после инфузии и оценка эффективности.				
Ведение осложнений после инфузии CAR-T	21-30 дней	① Синдром высвобождения цитокинов (CRS) ② Нейротоксичность, ассоциированная с клетками-эффекторами иммунного ответа (ICANS) ③ Профилактика инфекций, связанных с иммуносупрессией ④ Лечение и контроль гематологической токсичности ⑤ Другая поддерживающая терапия	180,000-260,000	25,714-37,143
Мониторинг и оценка эффективности после инфузии CAR-T:		① Анализы крови (в биохимические показатели, маркеры инфекции и др.) ② Инструментальные визуализационные исследования ③ Определение CAR-T-клеток и оценка функции иммунной системы ④ Оценка опухолевого процесса: выявление минимальной остаточной болезни (МОБ)		

Приживление гранулоцитов после инфузии гемопоэтических стволовых клеток				
Общая госпитализация	57-68 дней	Стоимость койко-места: 2 000 юаней/день. Стоимость медицинских услуг: 1 000 юаней/день. Стоимость услуг сестринского ухода: 900 юаней/день. Фармацевтическое обслуживание: 2 000 юаней/ неделя	222,300-265,200	31,757-37,886
Общая сумма (включая шаги 1,2,3,4)		Все вышеперечисленное	956,300-1,259,200	136,614-179,886
Вышеуказанные расходы являются ориентировочными и основаны на текущем физическом состоянии пациента. По мере прогрессирования заболевания и изменения состояния пациента план лечения может измениться, и стоимость может варьироваться.				

В стоимость включено:

1. Одноместная палата
2. Все необходимые диагностические исследования согласно плану лечения
3. Лекарственная терапия, клеточная иммунотерапия и другие вмешательства согласно плану
4. Стандартные медицинские услуги, консультации врача, обследования, лабораторные анализы и т. д.

В стоимость не включено:

1. Питание
2. Лекарства при выписке
3. Экстренное лечение осложнений (тяжёлые инфекции, CRS, CRES, реанимация)
4. Ведение сопутствующих заболеваний
5. Неотложная медицинская помощь
6. Личные расходы, такие как телефонные переговоры, авиабилеты.

Условия оплаты:

Первоначальный депозит: при поступлении в стационар требуется внести минимальный первоначальный депозит в размере 40,000 долларов США (эквивалентно 288 000 юаней). Этот депозит будет зачтен в счет ориентировочной общей стоимости лечения.

Окончательный расчёт: Оставшаяся сумма подлежит оплате после окончания лечения. Любые дополнительные расходы, понесенные в процессе лечения, будут добавлены к окончательному платежу, а неиспользованные средства из первоначального депозита будут возвращены.

ВАЖНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЕЧЕНИЯ:

Учитывая сложность состояния пациента, мы настоятельно рекомендуем запланировать индивидуальную онлайн-консультацию с доктором Цзян, нашим ведущим гематологом, имеющим большой опыт ведения диффузной В-крупноклеточной лимфомы.

Эта эксклюзивная консультация по предварительной записи предоставит вам и вашей семье:

1. Подробную оценку вашего текущего состояния.
2. Предварительные рекомендации по лечению, адаптированные под ваши потребности.
3. Возможность напрямую задать важные вопросы ведущему специалисту

В рамках нашей поддержки международных пациентов стоимость этой консультации составляет 150 USD за 30 минут. В связи с напряженным клиническим графиком доктора Цзян доступное время ограничено, поэтому мы просим вас подтвердить вашу заинтересованность как можно раньше, чтобы забронировать время приема.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Логотип GoBroad Healthcare Group

Мы предоставляем бесплатные услуги перевода на английский язык. Для других языков может быть предоставлен профессиональный переводчик по запросу (100 USD за 30 минут), или вы можете воспользоваться услугами своего переводчика.

Важные примечания

(1) Вышеуказанный предварительный план лечения основан на информации, предоставленной пациентом и/или его представителем. После поступления в стационар будет проведено комплексное повторное обследование. При наличии существенных расхождений между фактическим состоянием пациента и ранее предоставленной историей болезни или результатами анализов план лечения и стоимость могут быть скорректированы соответствующим образом после обсуждения с пациентом и/или его законным представителем.

(2) Что касается побочных эффектов CAR-T терапии, в частности синдрома высвобождения цитокинов (CRS) и нейротоксичности, рекомендуется тщательный мониторинг и своевременное вмешательство. Частота CRS зависит от индивидуальных особенностей, и в госпитале действует комплексная система реагирования.

После завершения лечения госпиталь предоставит подробные отчёты и план последующего наблюдения, чтобы обеспечить пациенту необходимую поддержку и мониторинг после возвращения домой, включая контроль восстановления, отслеживание возможных побочных эффектов и корректировку терапии при необходимости.

(3) За одну неделю до госпитализации необходимо предоставить свежие результаты внешних анализов и общий отчёт о состоянии пациента, такие как:

- Результат общего анализа крови (ОАК) за последнюю неделю для оценки риска угнетения костного мозга или инфекции.
- Результат анализа о функции печени и почек, а также отчеты о функции сердца, чтобы убедиться, что пациент может переносить химиотерапию.
- Маркеры инфекций, чтобы подтвердить, нет ли у пациента тяжелой инфекции.
- Оценка физического состояния, особенно для проверки на симптомы реакции "трансплантат против хозяина" (РТПХ).
- Результат анализа о группе крови и резус-факторе, для подготовки к использованию донорских клеток во время лечения.

Мы предоставляем комплексные услуги для иностранных пациентов, включая помощь с визой, медицинский перевод и сопровождение, дистанционные консультации и поддержку в реабилитации.

Мы понимаем, что получение медицинской помощи за границей — это серьёзное физическое и эмоциональное испытание как для пациентов, так и для их семей. Наш госпиталь предоставляет многоязычную поддержку, учитывает культурные особенности, организует индивидуальное питание, помощь с проживанием и транспортом, а также услуги сопровождения семьи, чтобы создать безопасную и комфортную среду. От встречи в аэропорту и момента госпитализации до восстановления и последующего наблюдения наша международная команда будет сопровождать вас на всём пути. Будьте уверены, мы стремимся предложить профессиональную помощь и чуткий уход, чтобы ваше лечение было понятным, комфортным и хорошо организованным.

Проф. Цзян Ин (Ying Jiang)
Госпиталь «GoBroad ShangHai ZhaXin»
Дата: 14 января 2026 г.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Логотип GoBroad Healthcare Group

Доктор Инь Цзян (Ying Jiang)

Заместитель главного врача, руководитель медицинской команды

Доктор Цзян занимает ряд значимых профессиональных должностей: является членом группы по лейкозам Комитета гематологии и Комитета по цифровой диагностике и лечению Шанхайской медицинской ассоциации. Ранее занимала должность лечащего врача в отделении гематологии Первой народной больницы Шанхая. Окончила Медицинский факультет Шанхайского университета Цзяо Тун, имеет степень доктора медицинских наук.
В 2014 году доктор Цзян проходила стажировку в лаборатории иммунологии клиники Mayo Clinic в качестве приглашённого исследователя. Она принимала участие в ряде научных проектов, финансируемых муниципальной комиссией по науке и технологиям, а также Национальным фондом естественных наук. Основные направления её научной деятельности включают персонализированный мониторинг минимальной остаточной болезни (MRD) и последующее лечение после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, а также иммунотерапию гематологических злокачественных заболеваний. Доктор Цзян является автором публикаций в журналах *Frontiers in Medicine* и *Journal of Clinical Hematology*.

Области профессиональной экспертизы:
диагностика и лечение злокачественных заболеваний системы крови; исследования в области иммунотерапии лимфом; проведение и сопровождение CAR-T-клеточной терапии; переходная («bridging») терапия перед трансплантацией.